BONUS 2

De 50 verslagfouten die je supervisor het vaakst corrigeert

50 fouten waardoor verslagen worden teruggestuurd; elk in de vorm «Geschreven → Correct → Waarom». Corrigeer je eigen verslag voordat je de rode pen van je supervisor tegenkomt.

Inhoud

Hoe je deze lijst gebruikt

Techniek en vergelijking — 6 fouten

Terminologie — 7 fouten

Lokalisatie, zijde en meting — 8 fouten

Bevindingen — 9 fouten

Conclusie — 8 fouten

Aanbeveling — 4 fouten

Kritieke bevinding en melding — 4 fouten

Opmaak en vóór ondertekening — 4 fouten

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe je deze lijst gebruikt

De fouten zijn gegroepeerd volgens de 4-stappenmethode: VOORBEREIDEN, DOORLOPEN, BESCHRIJVEN, SAMENVATTEN.

> *De meeste verslagfouten komen niet voort uit gebrek aan kennis, maar uit gewoonte. En een gewoonte is te corrigeren zodra je haar eenmaal opmerkt.*

STAP IN DE METHODE	BIJBEHORENDE FOUTENGROEPEN
VOORBEREIDEN	Techniek en vergelijking
DOORLOPEN	Bevindingen (overslaan en belangrijke negatieve bevindingen)
BESCHRIJVEN	Terminologie · Lokalisatie, zijde en meting · Bevindingen
SAMENVATTEN	Conclusie · Aanbeveling · Kritieke bevinding en melding · Opmaak en vóór ondertekening

1. **Lees een week lang elke dag één groep.** Acht groepen, acht dagen.
2. **Leg elk verslag dat je supervisor corrigeert naast deze lijst.** Als dezelfde fout twee keer terugkomt, zet hem dan op je checklist.
3. **Gebruik vóór ondertekening de verslagchecklist op één pagina.** De punten op de lijst zijn een samenvatting van deze 50 fouten.

Praktijk van de instelling

Als het verslagformat of de terminologievoorkeuren van je afdeling afwijken van de voorbeelden hier, geldt de regel van je afdeling. Het eigenlijke doel is het principe te pakken: een helder, afgewogen, vergelijkend verslag dat de vraag beantwoordt.

GROEP 1

Techniek en vergelijking

6 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
01	Het veld techniek is leeg gelaten.	«CT hersenen zonder contrast; axiale coupes beoordeeld in hersen- en botvenster.»	*Zonder te weten welk onderzoek onder welke omstandigheden is beoordeeld, kan de lezer de zeggingskracht van de bevindingen niet wegen.*
02	«CT abdomen met iv contrast.»	«CT abdomen-pelvis met iv contrast, portaalveneuze fase.»	*De fase bepaalt of een bevinding zichtbaar is; zonder informatie over de arteriële fase kan actieve bloeding niet worden beoordeeld.*
03	Technische beperking niet vermeld (bewegingsartefact, onvoldoende inspiratie).	«Beoordeling van de fossa posterior beperkt door bewegingsartefacten.»	*Als een beperking niet vermeld wordt, leest de zin «geen bevindingen» betrouwbaarder dan hij werkelijk is.*
04	«Vergeleken met het vorige onderzoek.»	«**[Datum]** vergeleken met de CT thorax van.»	*Zonder datum en modaliteit is niet te verifiëren met welk onderzoek is vergeleken.*
05	Er is niet vergeleken terwijl er een eerder onderzoek was.	«Vergeleken met het vorige onderzoek is de grootte van de nodus **[.. mm]** van **[.. mm]** toegenomen.»	*De eigenlijke vraag bij een vervolgonderzoek is meestal de verandering; zonder vergelijking beantwoordt het verslag de vraag niet.*
06	«Vergelijking: geen.»	«Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.»	*«Geen» is vaag: niet in het systeem, of niet naar gekeken? Een duidelijke zin neemt die vraag weg.*

GROEP 2

Terminologie

7 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
07	Bij CT «hyperintense laesie».	Bij CT «hyperdense laesie».	*Bij CT gebruik je densiteit, bij MRI signaal, bij echo echogeniciteit; een verkeerde term wekt de indruk dat je de modaliteit niet kent.*
08	Bij echo «hypodense massa».	Bij echo «hypo-echogene massa».	*Echogeniciteit is een term die specifiek is voor echografie.*
09	Bij een cyste «hypo-echogeen».	Bij een eenvoudige cyste «anechogeen».	*Anechogeen en hypo-echogeen betekenen een verschillende inhoud; de diagnose eenvoudige cyste berust op dit verschil.*
10	«Tumor gezien.»	«**[.. mm]** massalaesie gezien.»	*Tumor is een histologische diagnose; een beeldvormingsbevinding wordt beschreven als massa of laesie.*
11	«Infiltraat» (voor elke opaciteit op een röntgenfoto).	Beschrijvende term zoals «consolidatie», «matglas», «reticulaire opaciteit».	*«Infiltraat» is vaag en betekent voor verschillende artsen iets anders.*
12	«Er is massa-effect.»	«Uitwissing van de sulci, compressie van de ipsilaterale ventrikel en **[.. mm]** midline shift.»	*De mate van massa-effect moet met maat en bevinding worden aangegeven; de klinische beslissing hangt daarvan af.*
13	«Binnen normale grenzen» (voor alles).	Noem de relevante organen kort één voor één: «Lever, milt en nieren normaal.»	*Het blijft onduidelijk wat er beoordeeld is; de lezer kan het overgeslagen orgaan niet opmerken.*

GROEP 3

Lokalisatie, zijde en meting

8 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
14	Zijde niet vermeld: «Pleuravocht.»	«Pleuravocht rechts.»	*Het ontbreken van de zijde kan bij ingrepen als thoracocentese of chirurgie tot ernstige fouten leiden.*
15	Verkeerde zijde blijven staan uit het sjabloon.	De zijde wordt een tweede keer gecontroleerd met de markering op het beeld en de aanvraag.	*Het is de gevaarlijkste van de kopieer-plakfouten; de zijde moet in Bevindingen en Conclusie gelijk zijn.*
16	«Laesie in de linkerlong.»	«Laesie in het superieure segment van de linkeronderkwab.»	*Informatie over kwab en segment is nodig zowel bij follow-up als bij de planning van bronchoscopie of biopsie.*
17	«Grote massa», «kleine nodus».	«[.. x .. mm] massa», «[.. mm] nodus».	*Bijvoeglijke naamwoorden zijn geen maat; verandering bij follow-up is alleen met getallen te beoordelen.*
18	Slechts één afmeting gemeten, vlak niet vermeld.	«In het axiale vlak [.. x .. mm], craniocaudaal [.. mm].»	*Een meting in een ander vlak geeft bij follow-up de valse indruk van toename of afname.*
19	Geen eenheid bij de maat: «Nodus 8.»	«Nodus [.. mm].»	*Een getal zonder eenheid kan verkeerd gelezen worden en is medisch-juridisch niet te verdedigen.*
20	Bij een leverlaesie «in de rechterkwab».	«Segment [..] in».	*Informatie over het segment is standaard voor chirurgische en interventionele planning.*
21	Bij een ribfractuur ontbreekt het nummer.	«Rechts [..]. rib, fractuur in de laterale boog.»	*Welke rib gebroken is, is nodig voor de follow-up en voor afstemming met het lichamelijk onderzoek.*

GROEP 4

Bevindingen

9 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
22	Gestopt bij de eerste bevinding; de tweede bevinding is overgeslagen.	Elke regio wordt elke keer in dezelfde volgorde doorlopen; ook de tweede bevinding wordt beschreven.	*«Stoppen zodra je iets vindt» (satisfaction of search) is de meest voorkomende oorzaak van overslaan.*
23	Belangrijke negatieve bevinding niet vermeld (bij een vraag naar appendicitis geen woord over de appendix).	«Appendix normaal van aspect; geen aanwijzingen voor acute appendicitis.»	*Als het orgaan waar de klinische vraag over gaat niet wordt genoemd, weet de clinicus niet of het beoordeeld is.*
24	Bij een vraag naar bloeding wordt het botvenster niet genoemd.	«In het botvenster geen fractuur van het calvarium.»	*Fractuurbeoordeling op een trauma-CT vereist het botvenster; als dat niet vermeld wordt, wordt aangenomen dat er niet naar gekeken is.*
25	Bevindingen vermengd met interpretatie: «Pneumonie gezien.»	In de Bevindingen: «Consolidatie met luchtbronchogram.» In de Conclusie: «Kan passen bij een pneumonie.»	*De Bevindingen bevatten de observatie, de Conclusie de interpretatie; als die twee door elkaar lopen, wordt het verslag moeilijk te verdedigen.*
26	Tubes en katheters worden niet genoemd.	«ETT-tip boven de carina **[.. cm]** erboven; tip van de CVK in de projectie van de vena cava superior.»	*De meest gestelde klinische vraag bij IC-foto's is de positie van lijnen en tubes.*
27	Andere structuren in het beeldveld overgeslagen (bovenbuik op CT thorax).	«In de afgebeelde coupes van de bovenbuik **[geen pathologie gezien/..]**.»	*Elke structuur in het beeldveld valt onder de verantwoordelijkheid van wie verslaat; bijnier- of leverlaesies worden vaak gemist.*
28	Dezelfde bevinding wordt in de Bevindingen drie keer herhaald.	Elke bevinding wordt één keer beschreven, onder het betreffende orgaan.	*Herhaling maakt het verslag langer en maakt het de lezer moeilijker de belangrijkste bevinding te vinden.*
29	Botlaesie niet beschreven: «Laesie in het bot.»	«**[Bot]** in **[.. mm]**, **[lytisch/sclerotisch]**, **[smal/breed]** laesie met overgangszone; periostreactie **[afwezig/aanwezig]**.»	*Het karakter van een botlaesie (overgangszone, matrix, periost) bepaalt de differentiaaldiagnose.*
30	Bij een vochtcollectie zijn inhoud en maat niet vermeld.	«**[.. x .. mm]**, perifeer aankleurend, met lucht erin **[afwezig/aanwezig]** collectie.»	*Het besluit tot drainage wordt genomen op basis van grootte, inhoud en wandkenmerken.*

GROEP 5

Conclusie

8 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
31	De Conclusie is een kopie van de Bevindingen.	In de Conclusie alleen relevante bevindingen en hun interpretatie, op volgorde van belangrijkheid.	*De Conclusie is de samenvatting en interpretatie van de bevindingen; een kopie laat zien dat er niet is geïnterpreteerd.*
32	De Conclusie beantwoordt de klinische vraag niet.	De eerste zin beantwoordt de klinische vraag: «Geen aanwijzingen voor acute appendicitis.»	*De aanvragende arts zoekt in de eerste zin het antwoord op zijn vraag.*
33	Incidentele bevinding als eerste, kritieke bevinding als laatste.	Een kritieke bevinding altijd als eerste; incidentele bevindingen helemaal aan het eind.	*De lezer leest vaak alleen de eerste regel.*
34	«Klinische correlatie aanbevolen» (in elk verslag, zonder motivering).	Schrijf op waarmee en waarom gecorreleerd moet worden: «Correlatie met laboratoriumontstekingsparameters aanbevolen.»	*Een ongemotiveerde aanbeveling tot correlatie bevat geen informatie en ondermijnt de betrouwbaarheid van het verslag.*
35	Lange en ontwijkende lijst van differentiaaldiagnosen.	Eerst de meest waarschijnlijke diagnose, daarna hooguit twee à drie realistische differentiaaldiagnosen.	*Een lijst van tien punten geeft de clinicus geen richting; de volgorde van waarschijnlijkheid wel.*
36	«Maligniteit niet uit te sluiten» (zonder motivering).	Beschrijf de bevindingen die voor of tegen maligniteit pleiten en de aanbevolen volgende stap.	*Een ongemotiveerd «niet uit te sluiten» leidt tot onnodige ongerustheid en een keten van onderzoeken.*
37	Mate van zekerheid onduidelijk: «Pneumonie?»	«Passend bij pneumonie» / «pleit voor pneumonie» / «mogelijk pneumonie» — kies welke het is.	*Een vraagteken is geen verslagtaal; de mate van zekerheid wordt met standaardformuleringen aangegeven.*
38	De verandering ten opzichte van het vorige onderzoek ontbreekt in de Conclusie.	«Vergeleken met het vorige onderzoek **[.. in de laesie]** afname.»	*Bij een vervolgonderzoek wordt de klinische beslissing op basis van de verandering genomen.*

GROEP 6

Aanbeveling

4 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
39	«Aanvullend onderzoek aanbevolen.»	«Voor karakterisering MRI van de hersenen met contrast aanbevolen.»	*Als niet vermeld staat welk onderzoek en waarom, kan de aanbeveling niet worden opgevolgd.*
40	Aan elke bevinding is een follow-upadvies toegevoegd.	Alleen een specifieke aanbeveling bij bevindingen die de klinische beslissing veranderen.	*Een onnodige aanbeveling betekent onnodig onderzoek, kosten en ongerustheid bij de patiënt.*
41	Er is een follow-upinterval vermeld waar men niet zeker van is.	«De noodzaak van follow-up moet volgens de actuele richtlijn samen met het behandelteam worden bepaald.» — of vraag het je supervisor.	*Een verkeerd interval kan de patiënt schaden; schrijf een getal niet op als je er niet zeker van bent.*
42	Behandeladvies opgenomen: «Er moet met antibiotica worden gestart.»	«Kan passen bij een pneumonie.»	*De behandelbeslissing ligt bij het behandelteam; het radiologieverslag levert diagnostische informatie.*

GROEP 7

Kritieke bevinding en melding

4 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
43	De kritieke bevinding staat in het verslag, maar is niet gemeld.	Meld het telefonisch en leg het vast in het verslag: «Aan het behandelteam **[uur]** gemeld.»	*De tijd tot het verslag gelezen wordt, kan voor de patiënt kritiek zijn.*
44	De melding is gedaan, maar staat niet in het verslag.	«**[Tijdstip]** in **[eenheid]** telefonisch gemeld aan de dienstdoende arts.»	*Een niet-vastgelegde melding kan medisch-juridisch als niet gedaan worden beschouwd.*
45	Vastlegging van de melding: «aan arts doorgegeven».	Aan wie (functie en afdeling), hoe laat, via welke weg en of er is teruggelezen.	*Een vage vastlegging maakt het onmogelijk de melding te verifiëren.*
46	De kritieke bevinding staat midden in de Conclusie.	De kritieke bevinding is de eerste zin van de Conclusie.	*Een clinicus die snel leest, stopt misschien bij de eerste regel.*

GROEP 8

Opmaak en vóór ondertekening

4 fouten · Geschreven → Correct → Waarom

NR.	GESCHREVEN	CORRECT	WAAROM
47	Er zijn vierkante haken of sjabloontekst in het verslag achtergebleven.	Vóór ondertekening [ ] en tekens «...» worden opgezocht en verwijderd.	*Achtergebleven sjabloontekst laat zien dat het verslag ongelezen is verstuurd.*
48	Naam van de patiënt, onderzoeksdatum of aanvraag komen niet overeen.	Identiteit van de patiënt, datum en type onderzoek worden met het verslag afgestemd.	*Een verslag bij de verkeerde patiënt is een van de ernstigste verslagfouten.*
49	Afkortingen gebruikt zonder uitleg (niet-gangbare).	Schrijf een niet-gangbare afkorting bij het eerste gebruik voluit.	*Een verslag wordt niet alleen voor radiologen geschreven, maar voor alle clinici.*
50	Dicteer- of typefout: «links» in plaats van «rechts», «hypo» in plaats van «hyper».	Lees het verslag vóór ondertekening één keer van begin tot eind.	*Een fout van één letter kan de betekenis van de bevinding omkeren.*

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Bonus 3 · Verslag per klinische vraag: 30 klinische vragen. Een groot deel van de fouten ontstaat doordat het verslag de klinische vraag niet beantwoordt; bekijk bij de 30 meest gestelde vragen wat het verslag beslist moet beantwoorden.

Voor de juiste zinsformuleringen **Bonus 1 · Bank Met 200 Conclusiezinnen** kun je terugkeren.